

INTRODUCTION :

- Sd asphyxique résultant de la submersion (totalité du corps dans l'eau) ou de l'immersion (face de la victime) en milieu liquide.
- L'une des principales causes de mortalité accidentelle chez l'enfant+++ (baignoire, piscine) et l'adulte (mer ou rivière).
- URGENCE grave : mort ou séquelles (cérébrales).
- Peut-être : **Primitive = noyade vraie** : épuisement ou sujet ne sachant pas nager.

Secondaire à une syncope : mécanismes divers : traumatique, choc thermodifférentiel, allergique....

PHYSIOPATHOLOGIE :

A- Syndrome asphyxique :

- Réaction à l'immersion : 3 stades

Laryngospasme Puis, remplissage d'estomac avec de grandes quantités du liquide et Finalement, levée du laryngospasme (après 1-2 minutes) et inondation de l'arbre trachéo-bronchique.

->Parfois, persistance du laryngospasme causant « **noyade à poumons secs** ».

- **Réflexes de plongée** : apnée, bradycardie, vasoconstriction périphérique, redistribution à la circulation coronaire et cérébrale.

- **Œdème pulmonaire** : interstitiel et alvéolaire.

B- Conséquences : gravité est respiratoire # pronostic est neurologique

1. Respiratoires :

- OAP HD ou lésionnel
- Eau de la mer --> altération de la MAC
- Eau douce --> altération du surfactant
- Particules inhalées --> atelectasies
- Inhalation du contenu gastrique --> aggravation de la DR

2. Cardiovasculaires :

- Hypovolémie
- Trb de rythme
- Défaillance myocardique

3. Neurologiques :

- Anoxie cérébrale +++
- HTIC retardée

4. Autres :

- Hypothermie
- Trb hydro-electrolytiques
- Trb de la coagulation

CLASSIFICATION :

→ **Stade 1 : Aquastress**

- Pas d'inhalation
- Symptômes en rapport avec l'angoisse : Tachycardie , hyperventilation , tremblements

→ **Stade 2 : Petit hypoxique**

- Inhalation minime puis extraction rapide
- Toux , dyspnée , tachypnée , cyanose des ext , hypothermie
- Quelques râles aux bases
- Conscience normale

→ **Stade 3 : Grand hypoxique**

- Tableau de détresse respiratoire
- Râles diffus
- Conscience variable

→ **Stade 4 : Anoxique**

- Tableau d'ACR ou en cours d'installation

PRISE EN CHARGE :

A. Dans l'eau :

- Extraction la plus rapide
- Maintien de l'axe cou-tête-tronc
- Maintien des VAS ouvertes
- 5 Insuflations : en absence de ventilation spontanée

B. Hors de l'eau :

1. Evaluation initiale: Neurologique (GCS) – Respiratoire (FR , coloration) – HD (Fc, marbrures)

2. Réanimation cardio-pulmonaire : si ACR

- Libération des VA
- Ventilation artificielle – compressions thoraciques au rythme 2/30
- Donner l'oxygène par un insufflateur manuel type BAVU dès que possible.

3. Gestes systématiques : Déshabiller + Sécher + Mettre à l'abri du vent + Couverture isothermique

4. Réanimation spécialisée : dès l'arrivée des secours

- MEC : VVP : SS isotonique (pas SG !), SNG , SU + Monitoring

+ Bilan : NFS + IS + B.rénal + glycémie + B. coagulation + GDS + Rx thorax / ECG , Echo/TDM selon contexte

- Maintien des fonctions vitales :

A : Libération des VAS + B : Ventilation au masque à haute concentration ($FiO_2 = 1$) + C : Continuer RCP si ACR – Correction des Trb H-E

5. TT spécifique :

a) Aquastress :

- Rassurer + Réchauffer + Contrôler glycémie

- Hospitalisation de 24h+++

b) Petit hypoxique :

- Vidange gastrique

- Hospitalisation de 48h

c) Grand hypoxique :

- Hospitalisation en USI

- Intubation + Ventilation mécanique

- Maintien hémodynamique

d) Anoxique :

- RCP

- Lutte contre les ACSOS + maintien de la Pr.perfusion cérébrale moyenne (PPC) > 60 mmHg

→ PAS de bénéfices des diurétiques & de la corticothérapie !!!!

→ ATBprolyaxie : si suspicion d'infection

6. Surveillance :

- Clinique : Etat de conscience, hémodynamique (PVC), respiratoire, diurèse

- Paraclinique Bilan de retentissement, Rx Thorax

CONCLUSION :

- Mortalité lourde, séquelles.

- PEC pré-hospitalière+++

- Intérêt de prévention+++ : ne jamais laisser d'enfant sans surveillance dans l'eau, se baigner en zone surveillée, respecter les fanions d'interdiction (couleur rouge), surveillance adapter des personnes à risque (handicap moteur...), apprentissage de la natation, éviter l'alcool...